EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 77982
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 26-01-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LANDY ISIDORO ALVAREZ MILLAHUAL			RUN	: 7.887.603-4
F.Nac	: 07-11-1956	Edad	: 67 AÑOS, 2 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: BELLAVISTA FRENTE ALA CASONA			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 23-01-2024	Fecha Egreso	: 26-01-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. C83.3-LINFOMA DE CELULAS B GRANDES

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

LINFOMA DE CELULAS B GRANDES
* CONGLOMERADO DE ADENOPATÌAS
TVP IZQUIERDA
HTA
DM TIPO 2

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. C83.3-LINFOMA DE CELULAS B GRANDES (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CON ANTECEDENTES DE LINFOMA DE CELULAS GRANDES, TRASLADADO DESDE HCHM LUEGO DE HABER RECIBIDO PRIMERA DOSIS DE QUIMIOTERAPIA.
PRESENTA CONGLOMERADO DE ADENOPATÌAS INGUINALES IZQUIERDAS, ESTAS INICIALMENTE VOLUMINOSAS, CON ABUNDANTE EXUDADO Y ÙLCERAS ASOCIADAS.
CULTIVO REGIONAL SE INFORMA SOBREINFECTADO CON SAMR RECIBIENDO TRATAMIENTO CON VANCOMICINA Y LUEGO SUSPENDIDA DEJANDO CLOTRIMOXAZOL FORTE INDICADO POR INFECTOLOGÌA.
YA EN NUESTRO CENTRO PACIENTE CON EVOLUCIÒN FAVORABLE, SIN DOLOR U OTRA SINTOMATOLOGÌA. EN REGIÒN INGUINAL SE EVIDENCIA LESIÒN DE MUCHO MENOR VOLUMEN, ACTUALMENTE SIN EXUDADO, SIN ERITEMA U OTRAS LESIONES APRECIABLES.
EN BASE A BUENA EVOLUCIÒN, CONTROLANDO EXÀMENES QUE MUESTRAN DISMINUCIÒN DE PARÀMETROS INFLAMATORIOS Y CLINICA FAVORABLE SE DECIDE ALTA CON HOSPITALIZACIÒN DOMICILIARIA PARA CONTINUAR SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÒN DE FORMA AMBULATORIA.

PLAN DE MANEJO:

ANAGESIA SOS
REPOSO
CURACIONES
CONTROLES AMBULATORIOS

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO
2. RÈGIMEN LIVIANO, TODO COCIDO
3. COTRIMOXAZOL 800/160 1 COMPRIMIDO CADA 12 HORAS VO POR 3 DÀIS MÀS, LUEGO 1 COMPRIMIDO VO LUN - MIER - VIER
4. ALOPURINOL 300 MG CADA 12 HORS VO
5. OMPERAZOL 20 MG VO DÌA
6. PARACETAMOL 1 GR CADA 8 HORAS VO SI DOLOR
7. METAMIZOL 300 MG CADA 8 HORAS VO SOS SI PERSISTE DOLOR
8. ENOXAPARINA 60 MG SC CADA 12 HORAS
9. ACENOCUMAROL 4 MG VO HOY Y MAÑANA, DOMINGO 2 MG Y CONTROL CON INR PARA DEFINIR ESQUEMA
10. PREDNISONA 20 MG VO POR 5 DÌAS, LUEGO 10 MG VO POR 3 DÌAS, LUEGO 5 MG VO POR 5 DÌAS SUSPENDIENDO FINALMENTE MEDICAMENTO
11. SULFATO FERROSO 1 COMPRIMIDO VO DÌA
12. ERITROPOYETINA 1 AMPOLLA SC LUNES - MIERCOLES Y VIERNES PERMANENTE
13. INSULINA NPH 18 U AM Y 12 U PM SC, AJUSTAR TERAPIA LUEGO DE CESE DE TERAPIA CON CORTICOIDES
14. CURACIONES AVANZADAS
15. CONTROL EN POLICLÌNICO DE CIRUGÌA EN 2 SEMNAAS
16. CONTINUAR CONTROLES POR EQUIPO DE HEMATOONCOLOGÌA
17. CONSULTAR EN URGENCIAS SOS

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

PATRICIO ALEXIS JARA VILLA
MEDICO TRATANTE
17346122-4

JEFE SERVICIO